보건복지부 보도자료

보도시점	2026. 1. 15.(목) 조간 2026. 1. 14.(수) 12:00	배포	2026. 1. 14.(수)

2015년 30.5%에서 2023년 9.1%로 예방 가능한 외상 사망률 꾸준한 감소 추세

-’23년 예방 가능한 외상 사망률 조사 결과 9.1% 추산, ’21년 대비 4.8%p 개선-

-권역외상센터 운영을 통한 외상 사망 예방의 경제적 가치는 **최소 3.5조 원** 추산-

보건복지부(장관 정은경)는 외상으로 사망한 환자 사례를 조사한 결과, 2023년도 **‘예방 가능한 외상사망률’**이 **9.1%**로 나타나 **이전 조사결과**(2021년 13.9%) **보다 4.8%p 개선**되었다고 발표하였다. 이는 **2015년 첫 조사에서 30.5%**를 나타낸 이후 **처음으로 한 자릿수로 집계**된 수치이기도 하다.

< 조사개요 >

예방 가능한 외상 사망률은 외상으로 사망한 환자 중 **적절한 시간 내에 적절한 치료가 제공되었다면 생존 가능성이 있었을 것으로 판단되는 사망자의 비율**로, 외상진료체계의 접근성·적시성·전문성을 종합적으로 평가하는 핵심 지표다. 보건복지부는 2015년도부터 2년 주기로 전국 단위 조사연구를 실시하고 있으며, 이번이 다섯 번째 조사이다.

이번 조사연구는 **국가응급진료정보망(NEDIS)**에 등록된 **2023년 외상 사망 통계**에 대한 데이터 분석과 305개 병원* 1,294건의 외상 사망 사례 표본을 대상으로 한 전문가 패널 기반 의무기록 조사를 병행하여 실시하였다.

* 권역외상센터, 권역응급의료센터, 지역응급의료센터, 지역응급의료기관

또한, 이번 연구에서는 **예방 가능한 외상 사망률 감소를 경제성 관점에서 평가**한 연구결과도 함께 제시하였다. 권역외상센터 설립·운영에 투입된 비용과 외상 사망 감소로 얻는 편익을 화폐가치로 환산해 비교하는 **비용-편익 분석** 방식으로 수행하였다.

< 예방 가능한 외상 사망률 조사결과 >

조사 결과, 예방 가능한 외상 사망률은 **2015년도부터 지속적인 감소 추세***를 보여, **권역외상센터 설치·운영*** 등 중증외상 진료체계 구축을 위한 정책적 노력이 효과를 내고 있는 것으로 나타났다.

* **예방 가능 외상 사망률** : **30.5%('15)** → 19.9%('17) → 15.7%('19) → 13.9%('21) → **9.1%('23)**
** **권역외상센터 수 : 8개소('15)** → 10개소('17) → 14개소('19) → 15개소('21) → **17개소('23)**

전국을 5개 권역*으로 나누어 분석한 결과 **경기·인천**이 6.4%로 전국에서 **가장 낮은 수치**를 보였으며, **대전·충청·강원·세종** 권역은 2021년 16.0%에서 2023년 7.9%로 8.1%p 낮아져 **가장 큰 개선**을 보였다.

* 2015년 조사연구부터 전국을 ①서울 ②인천·경기 ③대전·충청·강원·세종 ④광주·전라·제주 ⑤부산·대구·울산·경상 5개 권역으로 구분하여 분석 실시

광주·전라·제주 권역도 2021년 21.3%에서 2023년 14.3%로 **7.0%p 개선**을 보였으며, **서울 4.2%p**(12.0%→7.8%), 부산·대구·울산·경상 2.1%p(13.5%→11.4%) 등 **모든 권역에서 예방 가능한 외상 사망률이 개선**되었다.

< 5개 권역별 예방 가능 외상 사망률 추이(단위 : %, %p) >

권 역	'15	'17	'19	'21	'23
전 국	**30.5**	**19.9 (△10.6)**	**15.7 (△4.2)**	**13.9 (△1.8)**	**9.1 (△4.8)**
서 울	30.8	30.2 (△ 0.6)	20.4 (△9.8)	12.0 (△8.4)	**7.8 (△4.2)**
경기/인천	27.4	16.7 (△10.7)	13.1 (△3.6)	10.0 (△3.1)	**6.4 (△3.6)**
대전/충청/강원/세종	26.0	15.0 (△11.0)	14.7 (△0.3)	16.0 (△-1.3)	**7.9 (△8.1)**
광주/전라/제주	40.7	25.9 (△14.8)	17.1 (△8.8)	21.3 (△-4.2)	**14.3 (△7.0)**
부산/대구/울산/경상	29.4	16.0 (△13.4)	15.5 (△0.5)	13.5 (△2.0)	**11.4 (△2.1)**

다만, 지역별 일부 의료기관으로부터 조사연구에 필요한 자료를 제출받지 못하여, **제출율이 낮은 지역의 경우**에는 **예방 가능한 외상 사망률이 실제보다 낮게 평가되었을 가능성**을 배제하기 어렵다.

* 지역별 자료제출율 : 광주 57.1%, 부산 60.9%, 서울 73.8%, 대구 75.0%, 전남 75.0% 등

책임연구원 아주대병원 정경원 권역외상센터장은 "과거 연구에서도 예방 가능한 사망사례가 많이 발생하는 기관이 자료 제출에 소극적인 경우가 많아, 이번 조사에서 자료 제출률이 낮은 지역의 조사 결과가 과소추계되었을 가능성이 있다" 라고 설명했다.

보건복지부는 추후 예방 가능한 외상 사망률 평가 시 더욱 정확한 결과 산출을 위해 의료기관의 자료 제출률을 높일 수 있는 방안을 마련할 예정이다.

< 권역외상센터 설치·운영의 경제적 가치 분석 >

권역외상센터 설치·운영을 위한 정부의 투자 비용은 물가지수를 보정하여 **2012년~2023년간 약 6,717억 원**으로 추계됐으며, 분석 기간 동안 **예방된 사망**은 **총 14,176명**으로 추정됐다.

예방된 사망자 수에 통계적 생명가치*(VSL, value of statistical life)를 적용해 예방된 사망의 가치를 추정한 결과, 편익은 약 **3.5조~19.6조 원** 범위로 제시되었다. 이를 **비용 대비 편익(BC Ratio)**으로 환산할 경우 **5.21~29.11**로 나타나 중증외상 진료체계 구축을 위한 비용 투자 대비 편익이 큰 것으로 확인되었다.

* 통계적 생명가치(Value of Statistical Life) : 개인이 사망 위험을 줄이기 위해 기꺼이 지불하려는 금액을 기반으로 추정된 화폐적 가치(2억 4,684만 원~13억 7,958만 원 추정)

이중규 공공보건정책관은 "외상환자 진료를 위해 **어려운 여건에서도 현장에서 최선을 다 해주시는 권역외상센터와 응급의료기관 등**의 **의료진** 여러분 덕분에 예방 가능한 외상 사망률이 지속적으로 개선되고 있다"라면서, "향후 **거점권역외상센터 지정**, **권역외상센터와 닥터헬기 간 연계 강화** 등을 통해 **중증외상 진료체계**를 **내실화**하고, 예방 가능한 외상 사망 사례를 지속적으로 줄여나가겠다"라고 밝혔다.

<붙임> 1. 권역외상센터 지정 현황
2. 예방 가능한 외상 사망률 조사 방법

담당 부서	공공보건정책관 재난의료정책과	책임자	과 장	임아람 (044-202-2640)
		담당자	주무관	최경희 (044-202-2639)

대한민국 정책브리핑 OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락

붙임1 권역외상센터 지정 현황

연번	시·도	의료기관명	최종지정	비고
1	전남	목포한국병원	’14.2.21.	목포시
2	인천	가천대길병원	’14.7.21.	
3	충남	단국대병원	’14.11.13.	천안시
4	강원	연세대원주기독병원	’15.2.12.	원주시
5	울산	울산대학교병원	’15.9.17.	
6	광주	전남대학교병원	’15.9.22.	
7	부산	부산대학교병원	’15.11.9.	
8	대전	을지대학교병원	’15.11.24.	
9	경기남	아주대학교병원	’16.6.13.	수원시
10	충북	충북대학교병원	’17.12.28.	청주시
11	경기북	의정부성모병원	’18.5.11.	의정부시
12	대구	경북대학교병원	’18.7.16.	
13	경북	의료법인안동병원	’19.9.20.	안동시
14	전북	원광대학교병원	’19.10.31.	익산시
15	제주	제주한라병원	’20.3.23.	
16	서울	국립중앙의료원	’23.7.21.	
17	경남	경상대학교병원	’23.12.29.	진주시

붙임2 예방 가능한 외상 사망률 조사 방법

① **(표본추출)** 국가응급진료정보망(NEDIS) 데이터베이스를 토대로 **369개 의료기관**의 **외상성 손상 사망환자 9,261명 모집단** 대상 추출

* **305개** 의료기관 총 **2,499건 사례** 층화표본추출

< 기존 연구와 비교 >

구 분	2015	2017	2019	2021	2023
모집단	237개 기관 7,228명	386개 기관 8,282명	363개 기관 8,482명	339개 기관 8,490명	369개 기관 9,261명
표본 추출	64개 기관 1,160명	118개 기관 1,862건	279개 기관 1,692건	265개 기관 1,688건	305개 기관 2,499건
유효 표본	934명 (80.5%)	1,251건 (67.2%)	1,002건 (59.2%)	929건 (55.0%)	1,294건 (59.6%)

② **(자료수집)** 119구급활동일지, 사망진단서(사체검안서), 의무기록 일체 사본, 영상 CD 사본

* 305개의 의료기관 중 자료미제출 기관 46개(폐업기관 2개소 포함)

③ **(사전조사)** 총 2,172건에 대해 조사지를 이용해 외상사망자 일반적 특성, 손상관련 정보, 이송·처치 관련 정보 등 조사

④ **(개별패널조사) 총 1,576건**에 대해 전문의 40명의 개별패널조사

* 2,172건 중 외상 사망 아님, 정보 부족, 기타 등 총 596건 제외

⑤ **(조별패널조사) 총 1,246건에 대해 예방 가능성 평가**

* 1,576건 중 사례 적합성에 대한 불합의 등 271건 제외, 검토위원회 28건 및 연구진 검토 필요 사례 31건 회부

⑥ **(외상사망검토위원회)** 조별패널조사에서 불합의된 사례(28건) 및 연구진 검토 필요 사례(31건) 재검토후 총 48개를 추가하여 **총 1,294건 예방 가능성 최종평가**